Entregable Individual U2-E02.

Datos iniciales

- **Nombre:** Gustavo Elías De La Cruz Castillo
- **Equipo:** FantasticFour_CitaMed-IA
- **Proyecto:** CitaMed-IA
- **Rol en el equipo:** Desarrollo (con antecedentes en Coordinación)

Proceso y mejora que analizaras:

Yo analizaré la transición del proceso manual de agendamiento (AS-IS) hacia el proceso automatizado de 24 horas con CitaMed-IA (TO-BE). La mejora busca optimizar el indicador de atención al cliente, reduciendo el tiempo de agendamiento por paciente y aumentando el Porcentaje de Automatización de la clínica.

Que debe cumplirse

- **Regla y paso donde se aplica:**

CitaMed-IA no debe permitir el agendamiento fuera de las reglas de negocio establecidas por la administración (por ejemplo, respetar la duración fija de consulta por especialidad, días laborables y horarios límite de cada médico). Se aplica durante la consulta de disponibilidad y registro en el sistema (paso 3 y 4 del proceso TO-BE).

Como sabes que esa regla existe:

- **Fuente que lo confirma**

Surge de la necesidad de respetar la planeación operativa de los médicos descrita en la delimitación e inicio/salida del proceso en el borrador U2-E01.

Quien la comprueba y con que información

El administrador/dueño de la clínica verifica que las reglas coincidan con la jornada laboral de sus especialistas. El área de Desarrollo valida que la lógica de la base de datos bloquee turnos inexistentes o fuera de horario.

Un ejemplo donde se cumple y que ocurre

Un paciente intenta agendar un domingo a las 10:00 PM con un especialista que solo atiende de lunes a viernes. CitaMed-IA reconoce las reglas de negocio y ofrece únicamente los primeros espacios disponibles del lunes por la mañana.

Un ejemplo donde no se cumple y que ocurre:

El sistema permite agendar a un paciente en un horario donde el médico no tiene consulta presencial programada. El paciente acude y no es atendido, generando descontento, pérdida de imagen del negocio y posibles gastos administrativos extraordinarios.

Tabla 1:

1. ***Que podría salir mal***

¿Que podría ocurrir?	**¿Por qué?**	**¿A quién o qué actividad afectaría?**	**¿Qué harías para prevenirlo y atenderlo?**
El personal de recepción se resiste a usar el nuevo panel administrativo o duplica registros.	Falta de capacitación en el nuevo flujo de trabajo o desconfianza en la automatización del sistema.	A la precisión de la métrica del indicador (% de automatización) y al control unificado de la agenda.	Capacitar al personal de recepción antes del despliegue, mostrando cómo la herramienta facilita su trabajo y reduce su sobrecarga de llamadas.
Caída del servidor o falta de conexión a internet en la clínica.	Fallas técnicas en la infraestructura local o interrupción del servicio en la nube donde corre el asistente.	A todo el proceso de agendamiento, paralizando las reservas automatizadas y saturando la recepción.	Diseñar un protocolo de respaldo manual (modo contingencia) y asegurar la sincronización periódica offline/online.

Fuente: Elaboración propia de Gustavo Elías De La Cruz Castillo

Tabla 2:

2. ***Que necesitamos***

¿Qué revisa?	**Tu respuesta**

Herramientas y datos: ¿Qué necesitamos?, ¿qué tenemos? y ¿qué falta comprobar?	Se necesitan servidores web, base de datos relacional de la agenda, panel administrativo para recepción y fórmula del indicador definida. Tenemos la delimitación del proyecto y la fórmula de automatización. Falta comprobar los horarios exactos y días laborables de cada médico.
Personas: ¿Quién lo usaría?, ¿quién revisaría? y ¿qué tendría que aprender?	El administrador de la clínica revisará las estadísticas de uso. Las recepcionistas deben aprender a monitorear la agenda centralizada. Desde Desarrollo comprobaremos el desempeño y la tasa de error del sistema.
Tiempo y recurso: ¿qué equipo, acceso, tiempo o costo requiere? y ¿con qué contamos?	Se requiere tiempo para la configuración de las reglas de negocio y capacitación. Contamos con los acuerdos de trabajo del equipo; falta confirmar el tiempo de instalación y puesta a punto en la clínica.

Nota. Las reglas específicas de la clínica, los horarios exactos de cada doctor y las regulaciones locales sobre protección de datos están en estado pendiente de confirmación en el borrador grupal.

3. Termina tu análisis

La mejora puede funcionar si el administrador de la clínica proporciona de forma exacta las reglas de horario de cada especialista y si el personal de recepción adopta el sistema como un aliado operativo, porque esto permitirá que el indicador de automatización sea verídico y el tiempo promedio de atención baje drásticamente.

Lo que falta comprobar es la compatibilidad del sistema con el método de administración actual de la clínica (Excel, libreta u otro software) y los horarios definitivos de los médicos.

Lo averiguaría realizando una entrevista formal con el dueño/administrador de la clínica e inspeccionando el método actual de registro de agenda.

4. Fuentes utilizadas

Borrador grupal U2-E01 FantasticFour_CitaMed-IA: Apartados "Acuerdo del equipo", "Indicador de Evaluación", "Datos Pendientes de Confirmación" y "Borrador AS-IS Proceso Actual".

Lineamientos operacionales de la clínica: Documentación interna para la gestión de turnos médicos y personal administrativo.

5. Uso de IA

Se utilizó ChatGPT como apoyo para la estructuración del documento, alineación de términos organizacionales y revisión de coherencia en el flujo de negocio.